

TEMA 5.16 • OFTALMOLOGÍA

misceláneos 1

PERFIL EUNACOM 6.02.1.024

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Síndrome de Ojo Seco: Causas, Diagnóstico y Manejo Básico

Constituye uno de los trastornos de la superficie visual anatómica general más preponderante en consultas rutinarias básicas por inflamaciones crónicas perennes, en una sintomatología muchas veces inespecífica.

• **Clínica referida Base:**

- Fastidio ocular genérico persistente insidioso y un leve **Ojo rojo** crónico a repetición fluctuante.
- Clásica queja e incomodidad base reportada por el paciente: **"Sensación continua e intensa de basurilla o arenilla ocular"**.
- Reflejo paradójico transitorio inflamatorio general superficial constante causará lagrimeo esporádico acuoso irritativo y escurrimiento de muy baja calidad lúbrica o moco deficiente, ocasionando en estadios finales las clásicas **epíforas** (Un ojo seco que llora).
- Puede derivar secundariamente a infecciones de base prolongante como Conjuntivitis crónicas repetitivas patológicas en círculo vicioso.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Complicación Agresiva Corneal del Ojo Seco Severo El resecamiento agónico epitelial degenerativo no resuelto en lubricación constante promueve severas microlesiones visualizadas con la fluoresceína y luz de Wood en cuadrantes inferiores, clásicamente denominada: **Queratitis Sicca (Queratitis Puntata Córneal Diseminada)**, o úlceras corneales per se en estadios críticos.

Etiologías del Ojo Seco

Su aparición no debe ser marginada al simple "cansancio por pantallas"; exige una exhaustiva indagatoria causal y un seguimiento biológico riguroso multivariabla sistémico, entre los perfiles endógenos resaltan:

- **Autoinmune Sistémica Insigne: Síndrome de Sjögren:** Es la causante más trascendental clínicamente exigida y patognomónica sistémica. Corresponde a la inflamación autoinmune patológica de múltiples glándulas exocrinas base, de las que las primeras manifestadas general del cuadro comprometen y mutilan simultáneamente las glándulas lagrimales (ojo seco / xeroftalmía) y las salivales superiores (boca seca/xerostomía).
- **Idiopática clásica pura:** De base y factor predominante senil asociado o genético funcional.
- Defectos de la fisiología estática neuro-mecánica de cobertura:
- - **Parálisis Facial:** El sujeto ve interrumpida la base motora involuntaria de oclusión completa en guiño parpadeal y oclusión corneal nocturna perimetral desproporcionada generándose resecamiento del frente aéreo. (Lagofthalmos).
- - Neuropatías locales anulando frecuencias o sensibilidad del parpadeo ciliar.
- **Proptosis Exoftálmica General Discrecional:** Alteraciones tiroideo endógenas graves como la patología biológica autoinmune clásica de la **Orbitopatía Distiroidea del Enfermedad de Graves-Basedow**, protrusión que abomba base el globo y sobrepasa y sobrestira márgenes anatómicos y de lubricación párpados naturales crónicos de base exponiendo a secarse gravemente las partes expuestas al medio.

Diagnóstico Clínico Estricto

Su objetivación y estándar oficial protocolizado de los escasos niveles funcionales básicos se apoya insustituiblemente en una validación:

- **Test de Schirmer:** Se instalan dos ínfimas y estandarizadas tiras de un especial Papel Filtro Clínico entrepuestas cuidadosamente al borde saco o fórnix de conjuntiva lagrimal palpebral bilateral inferior externo. El ojo cerrado impregnará y desplazará fluida humedad en los milímetros biométricos del filtro en 5 min, cuantificando categóricamente frente a valores pautas y diagnosticando formal real si la producción basal total del sujeto y reserva base ha de ser catalogado de moderada deficiente estricta o severa, corroborando visual hipolacrimia biológica verdadera médica y desmentir psicomorfismo de síntomas.

Tratamiento de Nivel General y de Fondo

- **Aporte Sintomático:** Sustitución empírica constante: Gotas base puras de **Lágrimas Artificiales purificadas** sin preservantes a demanda constante según la sintomatología crónica perenne. Frecuentemente agregando para alivios temporales largos de media noche, formas mucho más robustas como lo son los densos y protectivamente oclusivos **Ungüentos lubricantes**.
- **Aporte Etiológico Patológico de fondo o Comórbido Integral Ojo Seco:** Atacar firmemente el diagnóstico original médico base autoinmune y de contexto integral total médico de cada paciente. (Ej. corticoides, antimaláricos, terapias en un Sjögren activo con factor reumatológico local). Tratar causas de parálisis funcional expuestas asociadas a fisioterapia de recubrimiento parcial parpebral.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Un pescador de cincuenta años consulta por una lesión triangular blanquecina que avanza desde el ángulo interno del ojo hacia la córnea derecha. Refiere que ha crecido en los últimos dos años y ahora tiene visión ligeramente distorsionada. ¿Cuál es el diagnóstico y cuándo está indicada la cirugía?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para misceláneos 1. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La pinguécula es conjuntival y no invade la córnea; el pterigión sí invade la córnea y puede producir astigmatismo y pérdida visual, requiere cirugía si compromete visión.
- Ambas, pinguécula y pterigión, se deben a exposición crónica a sol, polvo y viento; la prevención es con lentes de sol.
- El xantelasma son depósitos lipídicos palpebrales que son marcador de dislipidemia; siempre solicitar perfil lipídico al encontrarlo.
- La leucocoria o pupila blanca tiene diferentes causas según la edad: en adultos cataratas, en niños catarata congénita y retinoblastoma.
- El retinoblastoma es el tumor ocular maligno más frecuente en niños, se manifiesta como leucocoria y puede detectarse en fotografías con flash.
- El leucoma es una cicatriz corneal que produce visión borrosa; el tratamiento definitivo es el trasplante de córnea en casos establecidos.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (MISCELÁNEOS 1)

PREGUNTA 1

Un pescador de cincuenta años consulta por una lesión triangular blanquecina que avanza desde el ángulo interno del ojo hacia la córnea derecha. Refiere que ha crecido en los últimos dos años y ahora tiene visión ligeramente distorsionada. ¿Cuál es el diagnóstico y cuándo está indicada la cirugía?

- A) Pinguécula; la cirugía se indica cuando produce síntomas cosméticos importantes
- B) Pterigión; la cirugía se indica cuando compromete la visión o el campo visual
- C) Leucoma corneal; la cirugía se indica con trasplante de córnea inmediatamente
- D) Pinguécula con invasión corneal; la cirugía se indica de inmediato
- E) Melanoma conjuntival; requiere biopsia urgente

PREGUNTA 2

Durante el examen físico de un paciente de cuarenta y cinco años, usted observa depósitos amarillentos en ambos párpados superiores. ¿Cuál es el significado clínico de este hallazgo y cuál es la conducta?

- A) Son pinguéculas palpebrales, hallazgo benigno sin implicancias sistémicas
- B) Son xantelasmas, marcadores de dislipidemia; solicitar perfil lipídico
- C) Son depósitos de calcio, hallazgo benigno propio del envejecimiento
- D) Son chalaziones múltiples, tratar con corticoides intralesionales
- E) Son verrugas seborreicas palpebrales, hallazgo benigno sin estudio adicional

PREGUNTA 3

Una madre trae a su hijo de cuatro meses porque notó que en las fotografías con flash un ojo se ve blanco mientras el otro se ve con el reflejo rojo normal. Al examen se confirma leucocoria en el ojo derecho. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A) Tranquilizar a la madre, es un artefacto fotográfico normal en lactantes
- B) Derivar urgente al oftalmólogo para evaluación de fondo de ojo
- C) Solicitar ecografía ocular ambulatoria y controlar en un mes
- D) Repetir las fotografías con mejor iluminación antes de hacer más estudios
- E) Indicar vitamina A porque puede ser deficiencia nutricional

RESUMEN: MISCELÁNEOS 1

Esta clase agrupa varias entidades oftalmológicas misceláneas frecuentes que el médico general debe conocer. La pinguécula y el pterigión son lesiones conjuntivales de aspecto similar que se diferencian por su extensión. La pinguécula es un depósito amarillento en la conjuntiva que no invade la córnea y no afecta la visión. El pterigión en cambio sí invade la córnea de manera progresiva y puede producir astigmatismo y pérdida del campo visual. Ambas se producen por exposición crónica al sol, polvo y viento, y la prevención es con lentes de sol. El pterigión requiere cirugía cuando compromete la visión. El xantelasma es un depósito lipídico amarillento en los párpados que es un marcador de dislipidemia. Ante un xantelasma el médico general siempre debe solicitar un perfil lipídico. La leucocoria es la pupila blanca o reflejo pupilar blanco en vez del rojo normal. En adultos la causa más frecuente es la catarata. En niños hay que pensar en catarata congénita y en retinoblastoma. El retinoblastoma es el tumor ocular maligno más frecuente en niños y se manifiesta principalmente como leucocoria, a veces visible en fotografías con flash como una asimetría del rojo pupilar. El leucoma es una opacidad corneal o cicatriz corneal que produce visión borrosa. La causa más frecuente es secundaria a infecciones corneales graves como queratitis bacteriana o herpética. El tratamiento es tratar la causa para evitar que progrese y en casos establecidos puede requerir trasplante de córnea.